

Reacciones adversas postvacunales (RAPV)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **reacciones adversas postvacunales (RAPV)** son manifestaciones clínicas no deseadas que ocurren después de la administración de una vacuna.

Aunque la mayoría son leves y autolimitadas, su reconocimiento es fundamental para **mantener la confianza pública en los programas de inmunización**, asegurar la **vigilancia epidemiológica** y garantizar la **notificación adecuada** de los eventos serios.

En Chile, el **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI-MINSAL)** cuenta con un **Sistema Nacional de Vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI)**, basado en las recomendaciones de la **OMS y la OPS**, el cual **registra, investiga y notifica** todos los eventos graves o inusuales asociados a vacunas.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa frecuentemente en casos clínicos sobre **reacciones locales severas, anafilaxia, fiebre alta post DTPa, o adenitis tras BCG**, y se espera que el médico reconozca **qué conducta seguir y cuándo notificar**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las reacciones postvacunales pueden deberse a tres mecanismos principales:

1. **Respuesta inmunológica normal (esperada):** parte del proceso fisiológico de generación de inmunidad (fiebre, dolor local).
2. **Hipersensibilidad a componentes del biológico:** por proteínas, adyuvantes o conservantes (anafilaxia).
3. **Error programático o de administración:** dosis incorrecta, vía inadecuada o mala conservación.

El término “**evento supuestamente atribuible a la vacunación**” (**ESAVI**) se usa cuando el evento ocurre temporalmente tras la vacuna, **sin implicar causalidad comprobada** hasta completar la investigación.

3. Clasificación de las reacciones adversas

a. Según gravedad

Tipo	Descripción	Ejemplo
Leves (esperables)	No comprometen el estado general, autolimitadas	Dolor, fiebre <38,5 °C, eritema local
Moderadas	Molestas pero sin riesgo vital	Fiebre >39 °C, llanto persistente, adenopatía regional
Graves	Comprometen la vida, hospitalización o secuelas	Anafilaxia, encefalopatía, shock, absceso estéril

b. Según tipo de reacción (OMS / MINSAL)

Tipo	Mecanismo	Ejemplos
Reacción relacionada con la vacuna	Inherente a su composición o mecanismo	Fiebre por SRP, adenitis por BCG
Error programático	Fallo en manipulación o aplicación	Absceso por técnica incorrecta
Coincidencia	Evento no causado por vacuna, pero temporalmente asociado	Convulsión febril por infección viral concomitante
Reacción idiosincrática	Respuesta imprevisible del huésped	Anafilaxia
Evento no clasificable	Información insuficiente	—

4. Manifestaciones clínicas frecuentes según vacuna

Vacuna	Reacciones esperables	Reacciones graves o notificables
BCG	Pústula local, costra y cicatriz	Adenitis supurativa, osteítis, diseminación (inmunodeprimido)
DTPa/dTpa	Dolor, fiebre leve, somnolencia	Llanto persistente >3h, fiebre >40 °C, encefalopatía
Polio (IPV)	Dolor local	Ninguna grave reportada
Hepatitis B	Dolor, fatiga	Anafilaxia excepcional
Neumocócica / Hib	Fiebre, irritabilidad	Reacción alérgica severa
SRP (Triple viral)	Fiebre 5–12 días postvacuna, exantema leve	Trombocitopenia, convulsión febril, anafilaxia
Rotavirus (oral)	Diarrea leve, irritabilidad	Invaginación intestinal (<1/100.000)
Influenza	Dolor local, febrícula	Síndrome Guillain-Barré (extremadamente raro)
Varicela	Exantema leve (1–3 lesiones)	Exantema diseminado en inmunodeprimido

VPH

Dolor local, síncope
vasovagal

Anafilaxia excepcional

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En la mayoría de los casos, las reacciones leves no requieren estudios.

Se solicitan exámenes solo ante **reacciones graves o inusuales**, para descartar causas coincidentes:

Situación	Examen sugerido
Fiebre >39 °C postvacunal	Hemograma, PCR, urocultivo (descartar infección)
Adenitis post BCG	Punción o cultivo si supura
Anafilaxia	Monitoreo clínico, registro de evento
Convulsiones	EEG o neuroimagen si persiste

6. Tratamiento y manejo clínico

a. Reacciones leves

- Sintomático: **paracetamol** (10–15 mg/kg c/6–8h).
- Compresas frías en el sitio de inyección.
- No suspender futuras dosis.

b. Reacciones moderadas

- Observación médica.
- Analgésicos y antitérmicos según necesidad.
- Reporte en ficha clínica si prolongadas o recurrentes.

c. Reacciones graves

1. Anafilaxia:

- Adrenalina IM 0,01 mg/kg (máx. 0,5 mg).
- Oxígeno, líquidos EV, traslado a urgencias.
- Notificar inmediatamente al PNI (formulario ESAVI).

2. Encefalopatía / convulsiones / shock:

- Manejo hospitalario.
- Investigación causal y notificación.

3. Adenitis BCG supurativa:

- Aspiración con aguja fina (no incisión).
- No antibióticos sistémicos salvo diseminación.

4. Invaginación intestinal (rotavirus):

- Sospechar ante vómitos biliosos o sangrado rectal.
- Derivar a urgencias; no aplicar dosis futuras.

7. Vigilancia y notificación (Chile – MINSAL)

Todos los **eventos graves o inusuales** deben notificarse dentro de **24 horas** al **Departamento de Inmunizaciones del MINSAL**, utilizando el formulario **ESAVI**.

Eventos notificables:

- Muerte o hospitalización postvacunal.

- Anafilaxia.
- Encefalopatía o convulsión prolongada.
- Shock o colapso.
- Adenitis supurativa post BCG.
- Cualquier evento no esperado médicamente significativo.

No se notifican: fiebre, dolor local o irritabilidad leves.

8. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Cicatriz hipertrófica tras BCG.
- Adenitis crónica post BCG.
- Convulsión febril post SRP (sin daño neurológico).
- Shock anafiláctico (extremadamente infrecuente).

b. Pronóstico

En más del **99,9 % de los vacunados**, los efectos adversos son **leves, autolimitados y sin secuelas**.

La **vigilancia activa y la educación a los padres** mejoran la adherencia al PNI y evitan falsas alarmas.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. Las **RAPV leves** son esperables y no contraindican futuras dosis.
2. **Fiebre o exantema leve tras SRP** a los 5–10 días es **normal**.
3. **Invaginación intestinal** es un evento raro del **rotavirus**, <1 por 100.000 dosis.

4. **Adenitis post BCG** debe **aspirarse**, no drenarse quirúrgicamente.
5. **Anafilaxia postvacunal** = **adrenalina IM inmediata + notificación MINSAL**.
6. **ESAVI** = evento temporalmente asociado, no necesariamente causado por la vacuna.
7. La **notificación de eventos graves** es **obligatoria para todo personal de salud**.

□ **Errores frecuentes:**

- Indicar antibióticos por pústula o costra normal tras BCG.
 - Considerar fiebre leve post DTPa como contraindicación futura.
 - No notificar una anafilaxia o adenitis supurativa.
 - Aplicar SRP a niño inmunodeprimido tras reacción previa.
 - No educar a los padres sobre reacciones normales esperables.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **reacciones postvacunales leves** (fiebre, dolor, irritabilidad) son normales y autolimitadas.
2. Las **RAPV graves** (anafilaxia, encefalopatía, adenitis BCG) deben **notificarse al MINSAL** dentro de 24 h.
3. **Adenitis post BCG** se maneja con **aspiración**, no incisión.
4. **Invaginación por rotavirus** es rara, pero contraindica dosis posteriores.
5. **ESAVI** = evento temporalmente asociado, requiere investigación para confirmar causalidad.
6. **Anafilaxia**: adrenalina IM inmediata (0,01 mg/kg).
7. La **educación y vigilancia activa** refuerzan la seguridad del PNI y la confianza pública.